Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 12ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810303

Processo nº **0041042-21.2025.8.17.2001**

AUTOR(A): DULCE MARIA MESQUITA PEDROSA

RÉU: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

SENTENÇA

Vistos etc.

DULCE MARIA MESQUITA PEDROSA, devidamente qualificada e por intermédio de Advogados a tanto constituídos, manejou a presente **AÇÃO ORDINÁRIA** em desfavor da **UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED-FERJ)**, pessoa jurídica de direito privado, igualmente identificada nos autos.

Em sua peça exordial, aduziu a autora, em suma, que é beneficiária de plano de saúde contratado junto à Ré, estando adimplente com todas as mensalidades e obrigações, e que a despeito de ter sido solicitada a cobertura contratual para fins de se tratar com utilização do fármaco denominado de LETROZOL 2,5 MG VO, a ser ministrado diariamente por 05 (cinco) anos, já que diagnosticada como portadora de carcinoma de mama (LUMINAL – CID10: C50), houve negativa a respeito. Relatou que já houve submetida a quadrantectomia e outros procedimentos, indicando-se o fármaco para ser utilizado no tratamento (hormonioterapia adjuvante). Pontuou acerca da indispensabilidade do fornecimento e utilização do fármaco para fins de se ter eficaz tratamento da doença e dos riscos à vida envolvidos. Sublinhou ter sido submetida a indevidos constrangimentos e que tais se afiguram aptos a gerar danos morais. Discorreu sobre os fundamentos jurídicos do pedido e após solicitar concessão de Antecipação de Tutela para fins de se ter imediata imposição à ré da obrigação de fazer consistente em assumir o ônus pecuniário do tratamento requerido, pleiteou pela final confirmação de dita Medida de Urgência e reconhecimento de incidência de danos morais na espécie, com imposição condenatória.

Houve deferida a tutela de urgência antecipando o direito material pertinente à imposição obrigacional pretendido pela parte demandante (Id 205362646).

Citada, a suplicada apresentou Contestação (Id 209361166), na qual, em síntese, explicou que não há obrigatoriedade para atendimento da cobertura contratual pretendida, vez que além de o medicamento solicitado a custeio não se encontrar listado nos arts. 17 e 18 da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, não se afigurando antineoplásico de uso ambulatorial, incide expressa vedação contratual a respeito. Defendeu a incidência na espécie do princípio *pacta sunt servanda* e a taxatividade do rol de procedimentos da ANS, frisando acerca do julgamento pelo STJ ERESP nº 1886929/SP e ERESP nº 1889704/SP. Sublinhou acerca da legalidade da previsão da cláusula contratual excludente, citando a respeito o art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, bem como o disposto no art. 17, § único, inciso VI, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, e da própria indispensabilidade de preservação da segurança jurídica e fiel aplicação e observância da normatização da atividade empresarial, inclusive a fim de evitar incidência de desequilíbrio econômico da pactuação. Frisou acerca da necessidade de observância aos Princípios da

vinculação contratual, do mutualismo, da solidariedade, de forma a evitar ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Expressamente negou ocorrência de prática ilícita a oportunizar incidência de danos morais, solicitando modicidade em arbitramento de verba compensatória para a hipótese de entendimento judicial diverso. Pleiteou pela improcedência da demanda.

É o relatório. Decido.

O feito comporta o julgamento antecipado na forma do art. 355, I do CPC, em razão do dissídio posto a deslinde se afigurar meramente de direito, sendo suficientes ao livre convencimento deste Juízo as razões até o momento esposadas.

Como visto, a hipótese em apreciação é a de imposição de obrigação de fazer consistente em se autorizar a cobertura contratual para fins de realização de tratamento, com assunção, pela Operadora de Seguro Saúde, do ônus pertinente ao fornecimento de específico medicamento, essa já contemplada em sede de antecipação de tutela.

Ressalto de logo que diante mesmo da assunção da prática da conduta consistente na negativa da autorização da cobertura contratual no que concerne ao tratamento medicamentoso a que se viu obrigada a se submeter a suplicante, solicitado tal pelo médico-assistente, incide incontrovérsia a respeito, significando dizer que tal não está meramente alegado, mas provado. Indicando ainda ser a análise da licitude ou não da conduta pertinente o ponto fulcral da demanda.

Assim, em analisando de plano a motivação apresentada pela suplicada para fins de justificar a conduta perpetrada e a cotejando frente às provas colhidas nos autos, tenho-a revestida de ilegalidade e, diante do contratado entre as partes, desprovida de razoabilidade.

Com efeito, sob pena de se vulnerar o indispensável equilíbrio contratual e injustamente se impor à autora, consumidora, situação de patente e injustificável prejudicialidade, tem-se inegável o reconhecimento da ilegalidade da imposição restritiva dita como inserta em cláusula do instrumento do pactuado entre as partes. Pois, de ciência, numa primeira perspectiva, cabe ao médico-assistente definir qual é o melhor tratamento para o paciente beneficiário da pactuação de saúde, não sendo razoável que a interpretação restritiva prevaleça na espécie. Sobrelevando anotar, em dito contexto, o entendimento de que *"o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário"* (AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017).

Ora, conforme relatório médico constante do Id 204112653, a paciente foi diagnosticada com "câncer de mama de alto risco" (CID 50.9), submetida a quadrantectomia e com indicação de tratamento medicamentoso com utilização do fármaco denominado de LETROZOL 2,5 MG VO, a ser ministrado diariamente por 05 (cinco) anos, isso a fim de reduzir risco de recidiva e morte. E, ademais, conforme já explicitado na Decisão de Id 205362646, concessiva essa da Antecipação de Tutela suscitada, em se aferindo a bula do medicamento denominado LETROZOL, acessível pelo site https://consultaremedios.com.br/letrozol/bula?srsltid=AfmBOopNsQ9dGjm40ArAU9Z2tpGNvGFIPULVNKB5htcQzC6vggidgBVZ, tem-se por perceptível que o medicamente é indicado para o tratamento câncer de mama. E, ademais, a atual Jurisprudência do STJ vem reconhecendo a abusividade da recusa de cobertura de tratamento mesmo quando em caráter *off-label*, quando contratualmente coberta a doença. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS PRESCRITOS POR MÉDICO ASSISTENTE. OBRIGATORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5, 7 E 83 DESTA CORTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória ao custeio de medicamento antineoplásico administrado pessoa falecida no curso da demanda, cujo tratamento foi realizado junto ao GRAAC. O pedido da recorrente consiste em afastar sua obrigação de reembolso, alegando ausência de cobertura contratual e irrelevância da prescrição médica, tendo em vista a alegada ausência de previsão no rol da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear medicamento antineoplásico prescrito para tratamento de cânce (ii) estabelecer se é possível o conhecimento do recurso especial quando a controvérsia exige reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O recurso especial não pode ser conhecido quando a reforma do acórdão impugnado exige reexame de cláusulas contratuais e do acervo probatório dos autos, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. A Corte estadual concluiu, com base nas provas e no contrato, que o medicamento prescrito se enquadra na cobertura obrigatória, não havendo perda de objeto com o falecimento da beneficiária, em razão da legitimidade dos herdeiros para pleitear o reembolso das despesas. 5. ***A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é abusiva a recusa de cobertura por plano de saúde de medicamento antineoplásico prescrito por profissional habilitado, mesmo que o uso seja off-label e que o tratamento se dê fora do rol da ANS, por***

se tratar de medida essencial à saúde do paciente. Precedentes. 6. O entendimento reiterado do STJ reforça que compete exclusivamente ao médico assistente a definição do tratamento adequado ao paciente, cabendo à operadora custear a terapia indicada, conforme previsto contratualmente e em atenção à boa-fé objetiva. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso não conhecido. (REsp n. 2.201.353/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025, destaquei).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO OFF LABEL. DEVER DE CUSTEIO. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. DANO MORAL. QUANTUM QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp n. 1.653.706/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020). 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, o que não se verifica no caso dos autos. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (REsp n. 2.204.765/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025, destaquei).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Ação de obrigação de fazer em que a parte autora, diagnosticada com neoplasia de mama bilateral, pleiteia o fornecimento do medicamento Lynparza (olaparibe) pela operadora do plano de saúde. 2. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, condenando a operadora do plano de saúde a custear o tratamento. O Tribunal de origem manteve a decisão, considerando devido o fornecimento do medicamento. II. Questão em discussão. 3. Há três questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do medicamento prescrito, ainda que se trate de fármaco off-label, não previsto no rol da ANS; (ii) saber se houve cerceamento de defesa ao não ser permitida a realização de prova técnica; e (iii) saber se há violação do art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/1998. III. Razões de decidir. 4. A Súmula n. 7 do STJ terá incidência quanto à produção de outras provas, quando o tribunal de origem afasta a alegação de cerceamento de defesa, por terem sido consideradas suficientes as provas apresentadas. 5. A Súmula n. 182 do STJ terá incidência quando não é impugnado o fundamento de capítulo autônomo de decisão monocrática. 6. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ que considera abusiva a negativa de cobertura pela operadora do medicamento prescrito, ainda que se trate de fármaco off-label, e que o plano de saúde tem o dever de cobrir fármacos antineoplásicos. (Súmula n. 83 do STJ). IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A revisão de provas para afastar a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida é inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 2. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando não for impugnado o fundamento de capítulo autônomo de decisão monocrática. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o tribunal de origem impõe à operadora do plano de saúde o dever de cobrir fármacos antineoplásicos, independentemente da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS e do uso off-label". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, §§ 4º e 13; Lei n. 14.454/2022.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.778.523/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.174.659/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025; STJ, AgInt nos EREsp n. 2.117.477/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/12/2024. (AgInt no AREsp n. 2.654.885/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025, destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE SOB AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO OFF LABEL. ABUSIVIDADE. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.83/STJ. 1. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. 2. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off-label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado. 3. O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes (AgInt no REsp n. 1.747.519/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 18/5/2020). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.037.487/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024, destaquei).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. ***Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes.*** *3.* ***Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"*** *(AgInt no AREsp n. 1.653.706/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020). 4. Agravo interno a que se nega provimento.* (AgInt no REsp n. 2.046.502/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

É de se salientar ainda que a constatação acima destacada importa em indicar inexorável conclusão de não ter tido a suplicada, quando do desenvolvimento da relação contratual e em especial quando da necessidade de utilização do plano de saúde, observância à imprescindível boa-fé contratual.

De fato, ao erigir como um de seus princípios fundamentais a boa-fé, o Código de Defesa do Consumidor, segundo nos ensina Eros Roberto Grau ("Interpretando o Código de Defesa do Consumidor; algumas notas", Rev. de Dir. do Consumidor, vol. 5, Ed. RT, jan/mar-1993, págs. 187/188.), impõe que tal seja entendida não como mera intenção, mas como imperativo objetivo de conduta, exigência de respeito, lealdade, que deve prevalecer desde a formação inicial da relação de consumo e vigorar em seu natural desdobramento, isso a fim mesmo de se tornar efetiva relação harmônica, de caráter sumamente transparente, preservando-se, daí, a dignidade, a saúde, a segurança, a proteção dos interesses econômicos do consumidor em face da presunção legal da sua vulnerabilidade no mercado de consumo, conforme previsão do art. 4.º de dito diploma.

De se explicitar que no cenário acima descortinado, a exclusão da cobertura afronta o princípio da boa-fé contratual, já que no momento da contratação a Operadora acenou com a perspectiva de dar cobertura aos tratamentos necessários ao consumidor, inclusive os mais modernos, atraindo-o, inegavelmente, à adesão, e, no entanto, quando necessário de tratamento, vê-se, o paciente, objetivamente desprotegido. Sendo certo que o entendimento quanto à obrigatoriedade de custeio de antineoplásicos orais, mesmo para uso *off-label*, permanece hígido, quando o medicamento tiver registro na ANVISA e tiver sido prescrito pelo médico do paciente, como no caso.

Doutra banda, tenho ainda como perceptível incidir plena ilegalidade da interpretação da hipótese vertente com o enquadramento da mesma à regra inscrita na já referenciada regra de exclusão do pactuado entre as partes, vez que incompatível com a cogente previsão do inc. IV, do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. Pois ao excluir da cobertura do contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar o custeio do tratamento requisitado em caráter de urgência, deu-se real subtração à suplicante do gozo de direito fundamental inerente à própria avença, colocando-o em significativa desvantagem, com perceptível vulneração ao princípio de boa-fé contratual. E, ademais, *"(...) Não pode a estipulação contratual ofender o princípio da razoabilidade, e se o faz, comete abusividade vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Anote-se que a regra protetiva, expressamente, refere-se a uma desvantagem exagerada do consumidor e, ainda, a obrigações incompatíveis com a boa-fé e a eqüidade"* (STJ - RESP nº 158.728/RJ). E, ainda, *" Lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida".* (STJ - REsp 466667/SP).

Oportuna a lembrança que a regra básica de interpretação dos contratos de consumo é a insculpida no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual *"as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor"*, ressaltando-se que tal regra não diz respeito apenas aos casos de dúvida, mas, sim, que se constitui em parâmetro obrigatório de aplicação dos princípios insculpidos em tal Diploma.

Destaque-se ainda por importante e pertinentemente à possibilidade de limitação de cobertura de contratos de saúde, que é plenamente lícito às Operadoras estabelecer quais as enfermidades serão abrangidas pela cobertura contratual respectiva, mas, não, os tratamentos médicos cabíveis. Nesse sentido, observe-se o seguinte trecho de voto proferido pelo Min. Ricardo Villas Bôas Cueva no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1953880/RJ (Terceira Turma, julgado em 30/05/2022, publicado no DJe de 02/06/2022, de todo pertinente à hipótese ora tratada.

"Assim, conforme afirmado, a jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. Eis, ainda, os seguintes precedentes: REsp nº 668.216/SP, Relator o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ de 2/4/2007; REsp nº 880.035/PR, Relator o Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 18/12/2006, e AG nº 1.137.474/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJ de 19/6/2009. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE MANIFESTA DA CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é uníssona no sentido de que é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde terapia ou tratamento mais apropriado para determinado tipo de patologia alcançada pelo contrato. Precedentes. 2. Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei 9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (Precedente: AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013).3. Agravo regimental não provido" (AgRg no AgRg no AREsp nº 90.171/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/9/2013, DJe 20/9/2013).

Ademais é de se lembrar também que em sendo tipicamente de adesão, o contrato de seguro pertinente à prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, no que concerne à interpretação de suas disposições, deve ser sempre favorável ao consumidor/contratante. E, como já visto, em incidindo plena caracterização da necessidade do implemento do tratamento medicamentoso em caráter de urgência, não se pode, por lógica, interpretar como sendo aplicável a cláusula restritiva de direito já destacada. Nesse sentido, referindo-se a contrato de seguro-saúde, vêm a calhar as ponderações explicitadas na seguinte ementa de julgado do STJ: *"O segurado é um leigo, que quase sempre desconhece o real significado dos termos, cláusulas e condições constantes dos formulários que lhe são apresentados. Para reconhecer a sua malícia, seria indispensável a prova de que, (1) realmente, fora ele informado e esclarecido de todo o conteúdo do contrato de adesão, e ainda, (2) estivesse ciente das características de sua eventual doença, classificação e efeitos. A exigência de um comportamento de acordo com a boa-fé recai também sobre a empresa que presta a assistência, pois ela tem, mais do que ninguém, condições de conhecer as peculiaridades, as características, a álea do campo de sua atividade empresarial, destinada ao lucro, para o que corre um risco que deve ser calculado antes de se lançar no empreendimento."* (REsp 86095/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 22.04.1996, DJ 27.05.1996 p. 17877).

É importante deixar registrado que a pacificação de anterior divergência jurisprudencial firmada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é em regra, taxativo (EREsp 1.886.929-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022), foi superada pela superveniente edição da Lei nº 14.454/2022, que deu nova redação ao art. 10º, §13 da Lei nº 9.656 e consolidou o caráter exemplificativo no rol da ANS. Com a nova redação, o referenciado dispositivo passou a prever:

"*(...)*

§13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais".

Daí, constatado o *overrruling* a respeito do tema, não ampara a Defesa a tese de que o rol da ANS é taxativo. Portanto, deve ser dado primazia ao tratamento sugerido pelo médico assistente, sobretudo porque há efetiva indicação de eficácia e prescrição médica específica a respeito. Ainda que os argumentos acima não fossem suficientes, registro que foi esclarecida a impossibilidade de outros meios de tratamento em razão da condição de saúde da paciente e a Ré nem mesmo apresentou substituto terapêutico.

Com base nestas premissas, reafirmo a conclusão de que o medicamento requerido pela parte autora deve ser fornecido pela demandada.

Diante da linha argumentativa já explicitada a conduta perpetrada pela demandada se mostra de fato abusiva. Pois objetivamente não se apresenta razoável que se exclua determinada opção de tratamento se a doença está contratualmente coberta e indicada por médico assistente como essencial e que, diante desta conduta, aplique-se cláusula que desequilibra a relação contratual, na prática inviabilizando o objeto do contrato pelo esgotamento financeiro da contratante aderente e submetendo-a a intensa tensão. Em assim agindo, causou-se à consumidora dano de ordem moral, suscetível de compensação pecuniária. Vez que, perceptível, em vindo a ter seu pleito de cobertura contratual injustificadamente negado pela demandada, passou a demandante por constrangimentos que não podem ser elencados como simplórios, irrelevantes, ou fruto de exagerada sensibilidade, especialmente se lembrando que já se encontrava à ocasião naturalmente fragilizada diante da própria doença que a acometia. Pois,

conforme já de há muito pretoriamente asseverado, *"Tratando-se de contrato de seguro-saúde sempre haverá a possibilidade de conseqüências danosas para o segurado, pois este, após a contratação, costuma procurar o serviço já em evidente situação desfavorável de saúde, tanto a física como a psicológica."* (STJ - REsp 657717/RJ). Sendo, aliás, no âmbito estadual, matéria já sumulada (Súmula 35 – *A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode da ensejo à indenização por dano moral*).

Veja-se que sendo negado tal pleito, viu-se a autora, a despeito da relação contratual existente, reitere-se, injustamente impedida de objetivamente gozar da justa expectativa que possuí relativamente aos serviços contratados. Sofrendo então injusto vilipêndio. Hábil a possibilitar a compensação pecuniária pleiteada, segundo, aliás, como visto, já pacificado no âmbito do STJ. Nesse sentido, além do já transcrito neste Julgado, observem-se as seguintes ementas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. "A previsão contratual de prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como ocorreu no caso. Assim, havendo recusa indevida de cobertura de tratamento, a condenação ao pagamento de danos morais é medida que se impõe, pois agrava a situação física e psicológica do beneficiário. Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.168.502/CE, rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe de 15/3/2018). Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.115.214/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, devendo, portanto, ser reconsiderada a decisão proferida pela Presidência desta Corte. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para a utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019). 3. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de cobertura de tratamento, em caráter de emergência/urgência, tendo em vista o risco à vida e à saúde da paciente. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.355.900/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. 1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a recusa de cobertura, por operadora do plano de saúde, para tratamento de urgência ou emergência durante o período de carência constitui conduta abusiva configuradora de danos morais indenizáveis" (AgInt no AREsp n. 2.101.326/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023). Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.052.979/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.).

Ademais, tenha-se sempre presente que a própria Constituição Federal consagra como principio fundamental, alicerce da República Brasileira, a "dignidade da pessoa humana", referindo-se tal ao atendimento às exigências básicas, elementares, do ser humano em convívio social para fins de ter-se existência digna e oportunização ao desenvolvimento de pontencialidades. Não se alcançando, a dignidade da pessoa humana, tão somente, com condições materiais adequadas, com liberdade e reconhecimento de seus direitos fundamentais e de personalidade. Mas, igualmente, com o perfeito atendimento a outros interesses, esses indissociáveis da existência humana, os quais, por assim o ser, merecem proteção para a perfeita aplicação da norma constitucional. Sendo, pois, daí palpável e legítimo o interesse em querer preservar-se a tranqüilidade da pessoa humana no seio social e, em sendo tal agredida, ter-se a devida compensação pecuniária, como forma de lenitivo. Cumpre ainda se observar que

em atuando profissionalmente, a demandada possui o dever de prestar escorreito atendimento a todos os seus segurados, esses reais consumidores, de modo a os resguardar, em sua inteireza, de danos. Exigindo a adoção de medidas que garantam a segurança dos consumidores no que tange ao atendimento da já referenciada expectativa de cobertura contratual. É, aliás, o que está expresso no art. 14, caput, e seu parágrafo 1.º, ambos da Lei 8.078/90.

Registre-se que pacificado o entendimento no sentido da desnecessidade de demonstração acerca da incidência dos danos morais respectivos, vez que de âmbito interno. Daí, já ter decidido o Superior Tribunal de Justiça que o reconhecimento de respectiva incidência *"Independe de reflexo patrimonial, pois, do contrário, estar-se-ia a reparar o dano econômico indireto. "* (STJ, 3ª Turma, Resp. 64.699-5-RO, rel. Min. Costa Leite, j. 19.11.96, DJU 16.03.98,IOB 10/195).

Relativamente ao *quantum* compensatório pelo reconhecimento do dano moral sofrido pela parte autora, tenho inicialmente que de há muito incide no âmbito do STJ a sugestão de parâmetros de fixação, pois dita Corte assim já se pronunciou: *"o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a esse título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso"* (REsp. n°s. 214.381-MG, 145.358-MG, e 135.202-SP, Rel. Min. Sálvio Figueiredo Teixeira, DJU, respectivamente, 29.11.99, 01.03.99 e 03.08.98).

Ora, em atenção aos critérios e princípios acima elencados e consideradas as peculiaridades do caso em questão tenho, relativamente ao grau de culpa da suplicada, que, diante das provas documentais constantes dos autos, houve perceptível inobservância da indispensável eqüidade da mesma no desenvolvimento do trato contratual avençado, propiciando plenas condições à respectiva ocorrência. Concernente às repercussões do fato danoso, tenho-os como relevantes, principalmente por ocorrer no momento em que a consumidora necessitava do devido respaldo econômico e de tranqüilidade para continuidade do tratamento a que vem sendo submetida e posterior recuperação. Destarte, consideradas as peculiaridades do caso em questão e tendo em vista os princípios de moderação e razoabilidade, entendo ser justo e necessário fixar o importe compensatório pertinente em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo tal imposição plenamente justificável para que de um lado se tenha a devida compensação pelos transtornos passados pelo autor e, de outro, medida verdadeiramente pedagógica, pois destinada a de tentar evitar a reiteração da conduta perpetrada pela demandada, explicitamente prejudicial aos seus contratantes/consumidores.

Face ao exposto, com arrimo nos fundamentos fáticos e jurídicos ora explicitados e em resolvendo o mérito da demanda e extinguindo o Processo com lastro no inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil, resolvo julgar integralmente procedente a pretensão entabulada nos presentes autos, para: *(i)* confirmar a Decisão Antecipatória de Tutela adrede deferida no sentido de impor à demandada a obrigatoriedade de custeio do tratamento médico na conformidade da solicitação do médico-assistente, inclusive assumindo o ônus relativo ao fornecimento do fármaco prescrito (LETROZOL 2,5,MG VO a ser ministrado diariamente por 05 (cinco) anos; *(ii)* reconhecer a incidência de danos morais na espécie, condenando, via de consequência, a demandada a pecuniariamente compensar a demandante, fazendo-o no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária a incidir a partir do presente arbitramento (súmula 362 do STJ) e de juros legais de mora, a partir da data da citação (art. 405 do CC), com cálculo nos termos do preconizado na Lei 14.905/2024; *(iii)* pela sucumbência havida, condenar a demandada: *(a)* a pagar honorários advocatícios em favor dos causídicos da demandante, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido por referida parte, que corresponde à soma do valor da compensação pecuniária arbitrada por danos morais com o valor do custo do procedimento cuja cobertura foi imputada à ré, tudo com fulcro no art. 85, §2º, do Diploma Legal acima referenciado, na Súmula 27 do TJPE e no atual entendimento firmado pelo STJ (Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 198.124/RS) e *(b)* a pagar os valores pertinentes às custas e despesas processuais a serem calculados sob o importe total do proveito econômico obtido pela autora nos moldes já referenciados, corrigidos monetariamente, a partir da data da propositura da demanda, com cálculo nos termos do preconizado na Lei 14.905/2024.

Publique-se e se intimem, observadas as cautelas legais.

Certificado o trânsito em julgado e inocorrentes pendências relativas ao custeio da atividade jurisdicional desenvolvida, remetam-se os autos ao arquivo com anotações de estilo, sem prejuízo de eventual posterior ingresso de cumprimento de sentença.

Certifique-se quanto a eventuais despesas processuais remanescentes, intimando o correlato devedor para recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem atendimento, oficie-se a Fazenda Pública Estadual na hipótese de débito superior a R$ 4.000,00, na forma do art. 3º, I do Provimento nº 3/2022-CM (DJe de 16/03/2022), ou, alternativamente informando ao Comitê gestor de Arrecadação caso inferior o débito, sempre indicando acerca da suspensão de exigibilidade em razão da parte gozar dos benefícios da justiça gratuita.

Em caso de oposição de Embargos de Declaração, renove-se de imediato a conclusão processual.

Para a hipótese de ser interposto Recurso de Apelação, proceda-se com a intimação da parte recorrida para que apresente Contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias. Encerrado dito prazo, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Recife, data da assinatura eletrônica

Dario Rodrigues Leite de Oliveira
Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: **DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA**
12/07/2025 17:52:29
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: **209561739**

25071217522960500000204061370

IMPRIMIR GERAR PDF